ПРАВОВОЙ ОТЧЁТ · СТОМАТОЛОГИЯ · БЕЛАРУСЬ

Аудио и видео в клинике

Правовые основания записи звука и изображения в кабинете и на ресепшене, требования к согласиям пациентов, ответственность по КоАП и УК, налоговые риски. Тезисы против камер с микрофонами.

Подготовлено: ZCode · законодательство по состоянию на 07.11.2026

PERSONAL DATA · HEALTHCARE COMPLIANCE · 2026

Содержание

0. Резюме (TL;DR) 2

1. Нормативная база (проверенные реквизиты) 3

2. Ответы на восемь вопросов 4

В1. Может ли камера писать звук в стоматологии РБ? . . . 4

В2. Надо ли предупреждать клиентов на стойке? Достаточно ли табличек в кабинете? . . . 4

В3. Видео + звук в кабинете, где лечат зубы: какие требования? . . . 5

В4. Нужны ли подписи под видео и звуком по отдельности? . . . 6

В5. Что грозит клинике за нарушение? . . . 6

В6. Может ли налоговая запросить записи камер? . . . 7

В7. Есть ли закон, обязывающий ставить камеры в стоматологии? . . . 8

В8. Нужно ли разрешение госорганов на камеры и запись звука? . . . 8

3. Тезисы для разговора с другом: почему камеры со звуком — плохая идея 9

4. Что сделать вместо аудио-камер (легальный контур) 10

5. Открытые вопросы («к живому юристу») 10

6. Источники 11

Документ: правовой анализ требований к аудио- и видеофиксации в частной стоматологической клинике Республики Беларусь. Реквизиты НПА сверены по открытым первоисточникам (pravo.by, etalonline.by, cpd.by, court.gov.by, minzdrav.gov.by) на 07.11.2026. Пункты, требующие сверки по платной ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE», помечены «(сверить)». Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Базовая величина: 45 BYN с 01.01.2026 (постановление Совета Министров от 20.11.2025 № 651) — все суммы пересчитаны от неё.

0. Резюме (TL;DR)

1. Камера со звуком в кабинете стоматолога — практически всегда незаконна: разговор при приёме фиксирует **специальные персональные данные** (здоровье) + **врачебную тайну** + **информацию о частной жизни**. По ст. 8 Закона № 99-З обработка специальных данных без согласия запрещена; по ч. 2 ст. 18 Закона № 455-З сбор информации о частной жизни — только с согласия.

2. Регулятор уже высказался прямо. НЦЗПД: «Законодательство не предусматривает осуществление видеосъемки пациентов на приеме у врача без их согласия»; по жалобе пациента клинику обязали удалить записи и прекратить обработку (кейс, ноябрь 2025). Отдельно: «само по себе видеонаблюдение не включает в себя аудиомониторинг (запись голоса)» — аудио требует собственного правового основания.

3. Табличка не заменяет согласие. Таблички обязательны для легального видеонаблюдения в общих зонах, но для аудио и съёмки приёма нужно отдельное информированное согласие каждого субъекта — пациентов, сопровождающих, сотрудников. Реализовать на 100% невозможно.

4. Для налоговой камеры со звуком бесполезны: у МНС собственный видеомониторинг, хронометраж (ст. 76 НК — медицина названа прямо) и СККО (онлайн-чеки с кассы). Громкие дела против стоматологий (сокрытие 5–10 млн руб. выручки) — при работающих камерах.

5. Обязанности ставить камеры нет — ни в лицензионных требованиях к меддеятельности, ни где-либо ещё (только объекты из перечней облисполкомов: массовое пребывание 100+ человек).

6. Ответственность реальна: КоАП ст. 23.7 (юрлицу до 50 БВ по ч. 4; должностному лицу до 100 БВ по ч. 2; до 200 БВ по ч. 3 за распространение), УК ст. 203 ч. 2 / 203-1 / 203-2, моральный вред по п. 2 ст. 19 Закона № 99-З — независимо от имущественного вреда, плюс предписания НЦЗПД (удалить записи, прекратить обработку).

7. В 2026 году регулирование ужесточается: на общественном обсуждении — законопроект, специально упорядочивающий обработку ПД при видеонаблюдении и аудиозаписи.

8. Рекомендация: видео без микрофонов — только общие зоны (вход, коридор, зона кассы), таблички, положение о видеонаблюдении, политика обработки ПД, срок хранения до 30 дней. В кабинете — не ставить. Аудио — не ставить вообще.

9 000 BYN	30 дней	1 жалоба	100+
максимум штрафа по ч. 3 ст. 23.7 КоАП (утечка архива записей)	ориентир НЦЗПД для срока хранения видеоархива	достаточно для внеплановой проверки НЦЗПД (кейс 11.2025)	человек единовременно — порог обязательного видеонаблюдения

1. Нормативная база (проверенные реквизиты)

Ключевые акты и их роль в вопросе. Все реквизиты — действующие редакции по состоянию на 07.11.2026.

Акт	Реквизиты	Роль в теме
Закон «О защите персональных данных»	от 07.05.2021 № 99-З (в силе с 15.11.2021)	согласие, специальные данные (ст. 8), обязанности оператора (ст. 16), меры защиты (ст. 17), моральный вред (ст. 19)
Закон «О здравоохранении»	от 18.06.1993 № 2435-XII (в ред. Закона от 08.07.2024 № 26-З)	врачебная тайна (ст. 46), согласие на медпомощь (ст. 44)
Закон «Об информации, информатизации и защите информации»	от 10.11.2008 № 455-З (в ред. от 10.10.2022 № 209-З)	информация о частной жизни и персональные данные — ст. 18
КоАП РБ	от 06.01.2021 № 91-З (в силе с 01.03.2021)	ст. 23.7 — нарушение законодательства о защите персональных данных
УК РБ	от 09.07.1999 № 275-З	ст. 203, 203-1 (введена в 2021 г. взамен ст. 179), 203-2
ГК РБ	от 07.12.1998 № 218-З	ст. 151 (нематериальные блага), ст. 152 (моральный вред), ст. 153 (честь и достоинство)
НК РБ, Общая часть	от 19.12.2002 № 166-З	ст. 76 (хронометраж — прямо для медуслуг), ст. 78 (доступ в помещение), ст. 79 (истребование документов)
Закон «О лицензировании»	от 14.10.2022 № 213-З (с 01.01.2023), гл. 30; постановление Совмина от 27.02.2023 № 154	лицензионные требования к стоматологии (п. 2.43); требований о камерах нет
Указ Президента	от 28.10.2021 № 422	Положение о НЦЗПД: проверки, предписания; обучение работников организаций здравоохранения; Реестр операторов
Приказы ОАЦ при Президенте	от 12.11.2021 № 195; от 20.02.2020 № 66	техническая и криптографическая защита ПД, классы информационных систем
Указ Президента	от 25.05.2017 № 187 + постановление Совмина от 30.12.2013 № 1164	обязательное видеонаблюдение — только объекты из перечней облисполкомов (массовое пребывание 100+ человек)
Постановление Совмина и Правления Нацбанка	от 06.07.2011 № 924/16 (действ. ред.)	кассовое оборудование: чек обязателен, частная стоматология принимает платежи через КХТ
Рекомендации НЦЗПД для здравоохранения	от 13.12.2024	официальный ориентир для клиник по обработке ПД (сверить текст в ЭТАЛОН)

Таблица 1. Нормативная база вопроса

2. Ответы на восемь вопросов

Формулировки вопросов — из запроса заказчика; ответы сгруппированы по правовым режимам.

В1. Может ли камера писать звук в стоматологии РБ?

Прямого запрета нет, но законно — только при согласии каждого записанного. Цепочка оснований:

• **Голос и изображение = персональные данные** (ст. 1 Закона № 99-З: «любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или лицу, которое может быть идентифицировано», в том числе через признаки физической идентичности). НЦЗПД подтверждает: изображения и голоса на видео — обработка ПД, требующая правового основания.

• **Запись звука — отдельная обработка**, не «часть» видеонаблюдения: п. 7 Рекомендаций НЦЗПД по обработке ПД в трудовой деятельности (утв. 18.01.2022): «само по себе видеонаблюдение не включает в себя аудиомониторинг (запись голоса)». У аудио должна быть своя правовая база — у клиники её нет.

• **В кабинете звук фиксирует разговор о здоровье = специальные персональные данные** (ст. 1 Закона № 99-З). П. 1 ст. 8: «Обработка специальных персональных данных без согласия субъекта персональных данных запрещается». Исключение п. 2 ст. 8 (обработка «в целях организации оказания медицинской помощи») адресовано медработникам с обязанностью врачебной тайны при оказании помощи — микрофон, пишущий всех подряд (сопровождающих, следующих пациентов, персонал), под него не подпадает.

• **Частная жизнь:** ч. 2 ст. 18 Закона № 455-З: сбор, обработка, хранение информации о частной жизни — с согласия лица, «если иное не установлено законодательными актами». Разговоры пациентов на ресепшене (о здоровье, деньгах, семье) — это она.

• **Позиция регулятора уже применена:** кейс НЦЗПД (ноябрь 2025, ИПС «Нормативка.by») — пациент обнаружил камеру в кабинете врача, проверка, вывод «организация здравоохранения нарушила правила обработки персональных данных», клинику обязали удалить записи и прекратить обработку.

Итог: писать звук может, но законно — только получив согласие каждого субъекта на аудио отдельно. Без такого контура — незаконная обработка ПД (ст. 23.7 КоАП) и сбор информации о частной жизни помимо воли (ст. 18 Закона № 455-З).

В2. Надо ли предупреждать клиентов на стойке? Достаточно ли табличек в кабинете?

Предупреждать — надо, но одной табличкой вопрос не закрывается.

• Для **видеонаблюдения в общих зонах** (вход, коридор, касса) FAQ НЦЗПД требует: законная цель + информационные таблички («работники и посетители должны быть проинформированы о видеонаблюдении с помощью специальных информационных табличек») + положение о видеонаблюдении (цель, зоны, срок хранения) + политика обработки ПД с открытым доступом.

• **Информирование не равно согласию.** Для аудиозаписи и для съёмки в кабинете табличка правового основания не создаёт: нужно согласие субъекта (ст. 4 п. 3 и ст. 5 Закона № 99-З; ч. 2 ст. 18 Закона № 455-З). Согласие должно быть конкретным и информированным, бремя доказывания его получения — на операторе (п. 7 ст. 5), поэтому форма должна быть доказуемой (письменная/электронная).

• Практический минимум: табличка на входе и на стойке («ведётся видеонаблюдение, без аудиофиксации»), отдельный блок согласия в договоре/листе записи, устное информирование администратором. Для аудио — отдельное явное согласие каждого; для телефонных разговоров НЦЗПД прямо требует согласия на их запись.

В3. Видео + звук в кабинете, где лечат зубы: какие требования?

Комбинация режимов — самый жёсткий сценарий:

1. **Специальные ПД (здоровье):** только с согласием (ст. 8 № 99-З) + обязателен «комплекс мер, направленных на предупреждение рисков» (п. 3 ст. 8).
2. **Врачебная тайна:** запись приёма фиксирует «факт обращения… состояние здоровья, сведения о наличии заболевания, диагнозе… иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи» (ч. 6 ст. 46 ЗОЗ) — архив записей = архив врачебных тайн. Обязанность сохранять тайну распространяется на всех, кто получил доступ (ч. 12 ст. 46): администраторы, IT-подрядчик, охрана, монтажники. Доступ к архиву ограничивается и учитывается.
3. **Частная жизнь:** ст. 18 Закона № 455-З (см. В1).
4. **Цель:** законная и достижимая менее интрузивным способом. «Контроль персонала» конфликтует с интересами пациента; НЦЗПД допускает камеру на рабочем месте лишь при специфических обстоятельствах (опасные условия, материальные ценности, непрерывный сервис) — стоматологическое кресло под них не подпадает.
5. **Техническая защита:** техкриптозащита ПД по приказу ОАЦ № 195 (от 12.11.2021) во исполнение п. 3 ст. 17 № 99-З; ИС с видео+аудио при подключении к открытым сетям — класс «3-спец» и выше.
6. **Организационный минимум:** ответственный за внутренний контроль, политика обработки с неограниченным доступом до начала обработки (п. 3–4 ст. 17), ознакомление и обучение работников. Для организаций здравоохранения обучение работников по защите ПД — обязанность по Указу № 422 (ежегодно до 15 ноября сведения об обучаемых, приказ ОАЦ от 12.11.2021 № 194).
7. **Срок хранения:** ориентир регулятора — «не более 30 дней» (разъяснение НЦЗПД от 27.11.2023 № 4-13/1221).
8. **Право отказа:** пациент вправе не дать согласие — отказать ему в помощи из-за этого нельзя; часть приёмов пройдёт вне записи, и система «контроля» будет неполной by design.

B4. Нужны ли подписи под видео и звуком по отдельности?

Требования «отдельной подписи под видео» и «отдельной под звук» в НПА нет — но по существу согласия должны быть раздельными:

• Согласие — «свободное, однозначное, информированное» волеизъявление по конкретной обработке (ст. 5 № 99-З). Видео на ресепшене, видео в кабинете и аудиофиксация — три разных состава данных и разные цели; НЦЗПД рассматривает аудиомониторинг как самостоятельную обработку (п. 7 Рекомендаций). Единая «галочка на всё» — классический риск: регулятор квалифицирует её как отсутствие действительного согласия.

• Практическая рекомендация: в согласии — раздельные блоки («видеофиксация в зонах общего доступа» / «видеофиксация при оказании медпомощи» / «аудиофиксация») с отдельной отметкой/подписью под каждым; каждый блок — с целью, составом, сроком хранения и способом отзыва.

• Форма: императивной письменной формы для аудио/видео-согласия нет (п. 4 ст. 5 допускает её установление отдельным законодательным актом — для записей приёма такого акта нет), но доказуемая письменная/электронная форма де-факто обязательна из-за бремени доказывания (п. 7 ст. 5). НЦЗПД допускает электронную фиксацию согласия, в том числе голосовое согласие при записи телефонного разговора — при информировании в начале разговора.

B5. Что грозит клинике за нарушение?

Административная ответственность — КоАП ст. 23.7. Протоколы составляют органы внутренних дел (материалы, как правило, передаёт НЦЗПД по итогам проверки), дела рассматривает судья районного суда:

Часть	Состав	Санкция	В BYN (БВ = 45)
ч. 1	незаконные сбор, обработка, хранение, предоставление ПД (физлицо)	до 50 БВ	до 2 250
ч. 2	то же лицом, которому ПД известны по служебной/профессиональной деятельности (владелец, директор, администратор)	4–100 БВ	180–4 500
ч. 3	незаконное распространение ПД (утечка архива записей)	до 200 БВ	до 9 000
ч. 4	несоблюдение мер обеспечения защиты ПД	физлицо 2–10 БВ; ИП 10–25 БВ; юрлицо 20–50 БВ	юрлицо 900–2 250

Таблица 2. Санкции ст. 23.7 КоАП РБ (без изменений 2023–2025 гг.)

Регуляторные меры: НЦЗПД проводит проверки (в том числе внеплановые по жалобе любого пациента) и выносит предписания об устранении нарушений и приостановлении/прекращении обработки (п. 23 Положения о НЦЗПД, Указ № 422); предписание обжалуется в суд, но записи к тому моменту уже удалены (кейс ноября 2025).

Уголовная ответственность (крайние сценарии): ст. 203 ч. 2 УК — нарушение тайны переговоров/сообщений с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (скрытая камера с микрофоном потенциально подпадает): до 2 лет

лишения свободы; ст. 203-1 УК — незаконные действия в отношении информации о частной жизни и ПД без согласия, повлёкшие существенный вред (до 2 лет; распространение — до 3 лет; введена в 2021 г. взамен ст. 179). Практика есть: тайная видеосъёмка работника с публикацией = 2 года ограничения свободы со штрафом 300 БВ (разъяснение Минского городского суда от 28.07.2025); ст. 203-2 УК — несоблюдение мер защиты ПД с тяжкими последствиями (утечка из архива).

Гражданско-правовая ответственность: моральный вред — ст. 152 ГК и п. 2 ст. 19 Закона № 99-З: «подлежит возмещению… независимо от возмещения имущественного вреда и убытков» — пациенту достаточно доказать сам факт нарушения прав при обработке ПД и нравственные страдания.

Лицензионные риски: прямой статьи «за камеры» в Законе № 213-З нет, но нарушение требований законодательства (включая ПД-законодательство, привязанное через лицензионные требования ст. 208) даёт цепочку предписание — приостановление — прекращение лицензии (ст. 34–39). Публичных кейсов аннулирования лицензии из-за ПД пока нет. Нетарифные риски: отток пациентов, репутация, конфликты с персоналом.

В6. Может ли налоговая запросить записи камер?

Может — но ей это не нужно, и камеры выручку не «доказывают» в обе стороны.

• Право **доступа в помещение** при выездной проверке — ст. 78 НК (по предписанию, с осмотром; воспрепятствование — ответственность). Право **истребовать документы и иную информацию** — ст. 79 НК: видеозаписи теоретически подпадают под «иную информацию, относящуюся к деятельности», но устоявшейся практики запросов архивов камер у клиник не выявлено. За непредставление истребованного — ст. 14.6 КоАП. (Дословные редакции ст. 78–79 — сверить по ЭТАЛОН.)

• **Реальные инструменты МНС:** (1) хронометраж — ст. 76 НК, где медицинские услуги названы прямо: наблюдение на объекте 7 и более дней подряд, фиксация фактической выручки в хронометражно-наблюдательную карту; при превышении декларированной выручки на 30% и более налоги пересчитывают за весь период; (2) налоговый видеомониторинг МНС — налоговая ставит собственное наблюдение и сопоставляет с кассой (кейс февраль 2026, myfin.by: видеомониторинг минской стоматологии, доначисления около 30 тыс. руб.); (3) СККО — онлайн-передача чеков в МНС: кассовое оборудование обязательно (постановление № 924/16), чек пациенту обязателен; «активные кнопки» и мимо-кассовые принтеры видны по сопоставлению потоков; (4) сопоставление внутреннего учёта (медкарты, листы записи, тетради администраторов) с кассой.

• **Дела против стоматологий — при работающих камерах:** сентябрь 2026 (neg.by): минская стоматология скрыла 10 млн руб. выручки за 5 лет (3,7 тыс. имплантов без документов), доначислено 5,7 млн; октябрь 2026 (news.by, ДФР КГК): сеть стоматологий в Гомеле — 2 уголовных дела, скрыто 5+ млн руб. Наличие камер этим клиникам не помогло.

Итог: формально архив камер может быть истребован как «иная информация» (ст. 79 НК), но неучтённых клиентов налоговая выявляет хронометражем, собственным видеомониторингом и онлайн-кассой. Камеры со звуком не являются средством учёта выручки — зато добавляют ПД-риски на любой проверке. При «серой» выручке аудио-архив становится доказательной базой против самой клиники при любой жалобе или проверке НЦЗПД/ОВД.

B7. Есть ли закон, обязывающий ставить камеры в стоматологии?

Нет. Проверенная цепочка:

• Лицензионные требования к медицинской деятельности (гл. 30 Закона № 213-З от 14.10.2022, постановление Совмина от 27.02.2023 № 154; стоматология — п. 2.43): требований о видеонаблюдении нет (по всем доступным обзорам и текстам; дословную сверку приложения к постановлению № 154 — по ЭТАЛОН).

• Обязательное видеонаблюдение в РБ — только для объектов, включённых в перечни облисполкомов/Мингорисполкома (Указ от 25.05.2017 № 187; критерии — постановление Совмина от 30.12.2013 № 1164: техногенная опасность, места массового пребывания от 100 человек и т.п.). Обычная частная стоматология под критерии не подпадает.

• Осенью 2026 г. принят Указ № 386 (новая редакция системы мониторинга: ежегодная актуализация перечней, участие бизнеса в финансировании) — вступает в силу через 3 месяца после опубликования; перечень своего города стоит мониторить, но стоматология на несколько кабинетов в зону риска не входит.

B8. Нужно ли разрешение госорганов на камеры и запись звука?

Отдельного «разрешения на установку камер» в РБ нет (кроме включённых в перечни объектов по Указу № 187). Но с момента включения записи клиника — оператор персональных данных:

• **Предварительного уведомления/регистрации в НЦЗПД не требуется** (Закон № 99-З уведомления о начале обработки не предусматривает). Единственное уведомление регулятору — о нарушениях систем защиты ПД: незамедлительно, не позднее 3 рабочих дней (ст. 16).

• **Реестр операторов ПД** (с 01.01.2024; Указ № 422, приказ ОАЦ от 01.06.2022 № 94): критерии — биометрические/генетические данные, более 100 тыс. субъектов, более 10 тыс. несовершеннолетних, специальная трансграничная передача. Обычная клиника не попадает; НЦЗПД поясняет: системы видеонаблюдения без уникальной идентификации в Реестр не вносятся. Осторожно с распознаванием лиц и голосовой идентификацией — это уже биометрия (прямого разъяснения НЦЗПД про голос как биометрию не найдено).

• **Обязательный орг-минимум** (ст. 17 № 99-З): ответственный за внутренний контроль; политика обработки ПД с неограниченным доступом до начала обработки; ознакомление и обучение работников; порядок доступа к ПД; техкриптозащита по приказам ОАЦ № 195/№ 66.

• **Для организаций здравоохранения** (включая частные): обучение работников по защите ПД + ежегодная отчётность в НЦЗПД до 15 ноября (Указ № 422, приказ ОАЦ № 194).

Итог: разрешение не нужно, но комплаенс-пакет нужен до первого включения камеры — иначе первая же жалоба пациента даст состав по ст. 23.7 КоАП.

3. Тезисы для разговора с другом: почему камеры со звуком — плохая идея

1. **Аудио не «входит» в видеонаблюдение.** Позиция НЦЗПД дословная: «само по себе видеонаблюдение не включает в себя аудиомониторинг (запись голоса)». Включив микрофон, клиника запускает новую обработку без правового основания.
2. **Звук в кабинете = данные о здоровье = специальные ПД.** Ст. 8 № 99-З: без согласия обработка запрещена. Медицинское исключение п. 2 ст. 8 рассчитано на медработников при оказании помощи, а не на микрофон, пишущий всех подряд.
3. **Регулятор уже зафиксировал позицию и применил её.** Кейс ноября 2025: камера в кабинете врача — проверка по жалобе пациента — предписание удалить записи и прекратить обработку. Порог входа для проблем минимальный.
4. **Табличка не заменяет согласие.** Для аудио нужно согласие каждого: пациентов, сопровождающих, курьеров, персонала. Пропустили одного — уже незаконная обработка. Телефонные разговоры на стойке — тоже требуют согласия.
5. **Архив записей — это архив врачебных тайн.** Ч. 6 и ч. 12 ст. 46 ЗОЗ: запись приёма = врачебная тайна, обязанность хранить её ложится на каждого, кто получает доступ (админ, IT-подрядчик, охранная фирма, монтажник). Одна утечка — ч. 3 ст. 23.7 КоАП (до 9 000 BYN), ст. 203-1/203-2 УК, моральный вред по п. 2 ст. 19 № 99-З независимо от убытков.
6. **На ресепшене микрофон пишет частную жизнь.** Ч. 2 ст. 18 № 455-З: сбор информации о частной жизни — только с согласия. Разговоры людей о диагнозах, деньгах, семье в зоне ожидания клиника собирать не вправе.
7. **Налоговой звук не нужен.** Неучтённых клиентов выявляют хронометраж (ст. 76 НК, медицина — прямо), собственный видеомониторинг МНС и онлайн-чеки СККО. Все громкие дела против стоматологий (10 млн, 5 млн руб. сокрытой выручки, уголовные дела) — клиники с камерами. Аудио-архив не защищает, а при проверке по ПД — компрометирует.
8. **Обязанности ставить камеры нет ни в одном НПА** — лицензионные требования меддеятельности о них молчат; обязательное видеонаблюдение — только объекты 100+ человек из перечней облисполкомов. Ставить «для галочки» нечего подтверждать.
9. **Правило ужесточается.** В 2026 г. на общественном обсуждении — отдельный законопроект об обработке ПД при видеонаблюдении и аудиозаписи (информирование, запреты, порядок). Встраиваться в аудио нужно ровно накануне появления прямых запретов.
10. **Бизнес-выгода нулевая, риски асимметричны.** От аудио в кабинете не выигрывает ни налоговый учёт, ни споры с пациентами (запись без согласия — сама по себе нарушение и слабое доказательство), ни качество услуг (есть протоколы, внутренние аудиты, отзывы). Зато риски — от предписания до уголовной статьи и потери репутации.
11. **Персонал и клиенты проголосуют ногами.** Пациент вправе отказаться от записи — и отказать ему в помощи нельзя; персонал получает камеру на рабочем месте, которую НЦЗПД допускает только в особых обстоятельствах. Итог: конфликты, текучка, отзывы «нас записывают на приёме».

4. Что сделать вместо аудио-камер (легальный контур)

Если камеры вообще нужны — минимальный законный набор:

1. **Только видео, без микрофонов** (физически не монтировать аудиоканалы). Зоны: вход, коридор, зона кассы. Кабинет врача — без камеры (либо полностью по сценарию В3, что почти никогда не оправдано).
2. **Пакет документов оператора ПД:** политика обработки ПД (публично, до начала обработки), положение о видеонаблюдении (цель, зоны, срок хранения до 30 дней, круг допущенных), назначение ответственного, журналы доступа, согласия работников (ознакомление под подпись).
3. **Таблички** на входе и в зонах съёмки; на сайте — раздел о видеонаблюдении и ПД.
4. **Техкриптозащита** по приказам ОАЦ № 195/№ 66 (классифицировать ИС; локальный архив без выхода в открытые сети — проще класс).
5. **Обучение работников** в НЦЗПД + ежегодная отчётность до 15 ноября (для организаций здравоохранения это обязанность по Указу № 422, а не опция).
6. **Налоговая дисциплина вместо «контроля камерами»:** КХТ с чеками на каждый приём (постановление № 924/16), выверка листов записи/медкарт и кассы, никаких «прямых» наличных — хронометраж по ст. 76 НК ловит расхождения за 7 дней наблюдения, а ст. 243 УК по итогам таких дел уже работает против стоматологий.
7. **Когда выйдет закон/законопроект 2026 о видеонаблюдении и аудиозаписи** — пересмотреть контур по его требованиям (следить: pravo.by, cpd.by).

5. Открытые вопросы («к живому юристу»)

Вопросы, которые нельзя закрыть без лицензированного юриста РБ:

• **Голос как биометрия:** прямого разъяснения НЦЗПД нет; в осторожном сценарии аудиофиксация с идентификацией по голосу = биометрические ПД (специальные данные с повышенными требованиями, потенциально Реестр операторов).

• **Правки Закона № 99-З от 16.03.2026 № 134-З:** числятся на pravo.by, текст правок открыто не доступен — сверить в ЭТАЛОН-ONLINE.

• **Итоговый текст законопроекта 2026** об упорядочении обработки ПД при видеонаблюдении и аудиозаписи (принятая редакция и сроки).

• **Дословная сверка** ст. 78–79 НК, приложения о меддеятельности к постановлению № 154 «О лицензировании», санкций ст. 243 УК и текста Рекомендаций НЦЗПД для здравоохранения от 13.12.2024 — по платной ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE».

• **Конкретные услуги клиники** (имплантация и пр.) и формы согласий на сложное медицинское вмешательство (Указ от 26.12.2005 № 619, постановление Минздрава от 15.04.2021 № 36) — отдельная от камер, но смежная тема оформления согласий.

6. Источники

Первоисточники, использованные при подготовке отчёта (проверены 07.11.2026).

Первоисточники НПА

Закон № 99-З «О защите персональных данных» — pravo.by/document/?guid=3871&p0;=H12100099

Закон № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» — pravo.by/document/?guid=3871&p0;=H10800455

Закон № 2435-XII «О здравоохранении» — etalonline.by/document/?regnum=V19302435

Закон № 213-З «О лицензировании» — minfin.gov.by/upload/gosznak/acts/zakon_14102022_213z.pdf; постановление № 154 — pravo.by/document/?guid=12551&p0;=C22300154

НК РБ — pravo.by/document/?guid=3871&p0;=hk0200166; ст. 76 — legaris.by (хронометраж)

КоАП ст. 23.7 — kodeksy-by.com/koap_rb/23.7.htm; УК ст. 203, 203-1 — avcd.by (зеркала текстов)

Указ № 422 — pravo.by/document/?guid=12551&p0;=P32100422; приказ ОАЦ № 195 — pravo.by/document/?guid=12551&p0;=T62104893

Указ № 187 — pravo.by/document/?guid=12551&p0;=P31700187; постановление № 1164 — pravo.by/document/?guid=12551&p0;=C21301164

Постановление № 924/16 (кассовое оборудование) — pravo.by/document/?guid=3871&p0;=C21100924

НЦЗПД (cpd.by — официальный сайт)

FAQ: видеонаблюдение, аудиозапись, медорганизации, биометрия — cpd.by/populyarnoye-na-sayte/otvety-na-chasto-zadavayemyye-voprosy/

Д.Г. Полещук «Видеонаблюдение и видеосъемка как обработка персональных данных» (18.10.2023) — cpd.by/storage/2024/02/

Разъяснение № 4-13/1221 от 27.11.2023 (срок хранения 30 дней) — cpd.by/storage/2025/01/

Реестр операторов ПД — cpd.by/zachita-personalnyh-dannyh/operatoru/reestr-operatorov-personalnih-dannih/

Н.А. Швед об административной ответственности по ст. 23.7 — cpd.by/storage/2024/04/

Кейсы и практика

Кейс НЦЗПД «камера на приёме у врача» (11.2025) — normativka.by/lib/document/142157

Рекомендации НЦЗПД для здравоохранения (13.12.2024) — normativka.by/lib/document/125790

Минский горсуд, разъяснение от 28.07.2025 (ст. 203-1 УК) — court.gov.by

Видеомониторинг МНС: стоматология, доначисления (02.2026) — myfin.by/article/money/43764

Стоматология скрыла 10 млн руб. (09.2026) — neg.by/novosti/otkrytj/

Сеть стоматологий в Гомеле, уголовные дела (10.2026) — news.by/news/obshchestvo/

Законопроект 2026 о видеонаблюдении/аудиозаписи — sb.by, belta.by

---

Дисклеймер: материал подготовлен в информационных целях по открытым источникам и не является юридической консультацией. Перед принятием решений — сверка редакций НПА по ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» и pravo.by, консультация лицензированного юриста Республики Беларусь.